

ICU 年次レポート ダイジェスト

2025年度

対象期間 2025年04月01日 ～ 2026年03月31日 にICU入室した **587例** | 作成 2026年10月

要旨

入室は**587例**、ICU死亡率は**3.6%**と6年で最も低い。重症度で補正した標準化死亡比（SMR）は**0.65**で、6年続けて信頼区間の上限が1を下回り、「重症度から予測されるより死亡が少ない」水準を保っている。

一方で、**再入室率が12.3%**と過去6年で最高になり、**院内死亡率は13.7%→16.6%**と上昇した。ICUを生きて退室した後に亡くなる患者が増えている。

病床は8床で、正午時点の在室は平均**7.1人**（利用率89%）、**満床の日が年間146日**あった。特定入院料の算定率は**74.9%**で、在室日数の約25%は管理料を算定できていない。

1. 今年度の全体像

ICU入室患者数

587 例

▲ 34例 前年度 553例

ICU死亡率

3.6 %

▼ 1.1 pt 前年度 4.7%

院内死亡率

16.6 %

▲ 2.9 pt 前年度 13.7%

標準化死亡比 SMR

0.65

▲ 0.07 前年度 0.57

再入室率

12.3 %

▲ 2.9 pt 前年度 9.4%

人工呼吸実施率

23.3 %

▼ 4.3 pt 前年度 27.7%

ICU在室日数（中央値）

3.0 日

6年間変わらず

在室患者数（正午時点の平均）

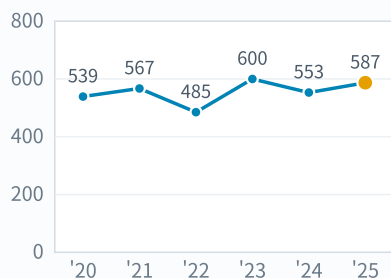
7.1 人

3～8人・8床の利用率89%

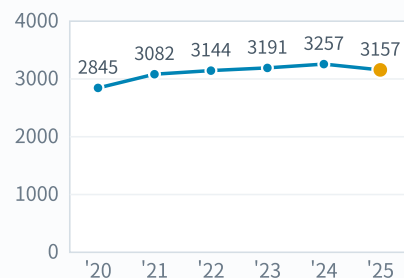
緑＝改善、赤＝悪化、灰＝良し悪しを判定しない指標。SMR＝院内死亡数 ÷ APACHE III による予測死亡数。

主要指標の年度推移（橙の点が2025年度）

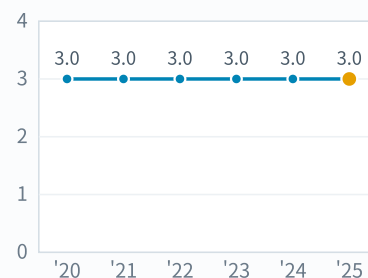
入室患者数 (例)



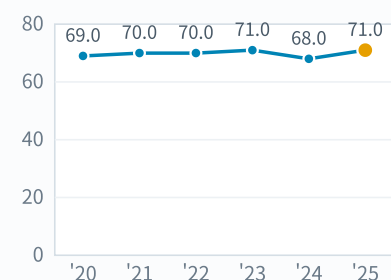
延べ在室日数 (日)



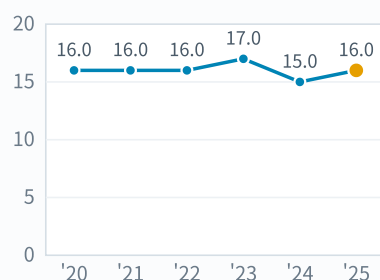
ICU在室日数 中央値 (日)



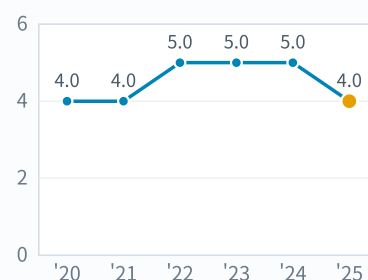
年齢 中央値 (歳)



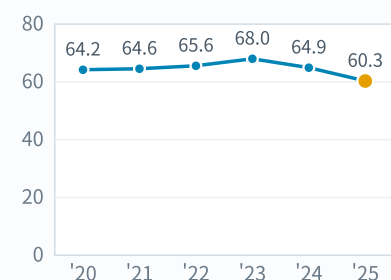
APACHE II 中央値 (点)



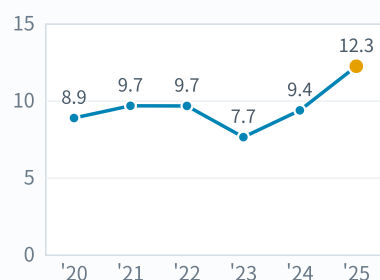
SOFA 中央値 (点)



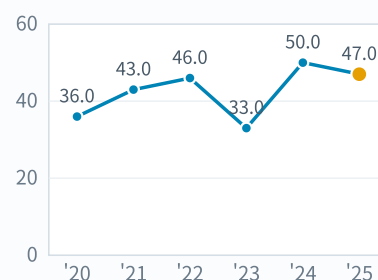
緊急入室 (%)



再入室 (%)



15日以上の長期滞在 (例)



縦軸は指標ごとに目盛りが違う。形の上下ではなく点に付いた数値を読む。

2. 押さえるべき3つの変化

01

患者は増えたが、在室は伸びていない

入室は前年度比+34例の587例。延べ在室日数は3,257日→**3,157日**と減少し、在室日数の中央値は3.0日。15日以上長期滞在は50例→**47例**。

意味するところ：同じ8床でより多くの患者を診ており、ベッドの回転が速くなっている。予定手術の割合が35.8%→**39.9%**に増えたことと整合する。

02

ICU死亡率は改善、院内死亡率は悪化

ICU死亡率は4.7%→**3.6%**、院内死亡率は13.7%→**16.6%**。

意味するところ：ICUを生きて退室した後に亡くなる患者が増えた。ICU内の成績だけを見ていると、この変化は見えない。

03

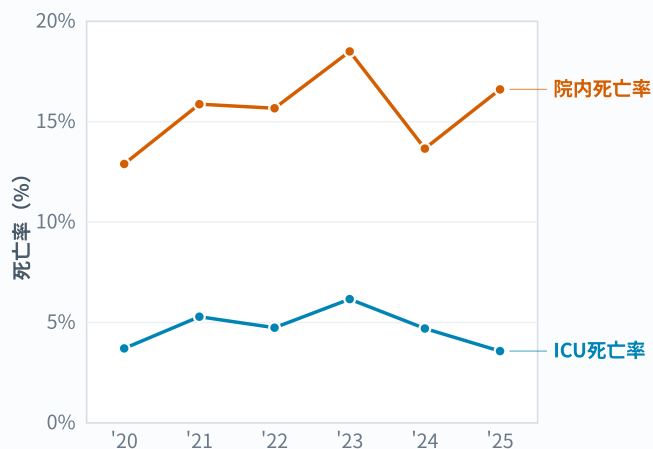
再入室率が過去6年で最高

9.4%→**12.3%**。それまでの5年間は7.7～9.7%だった。

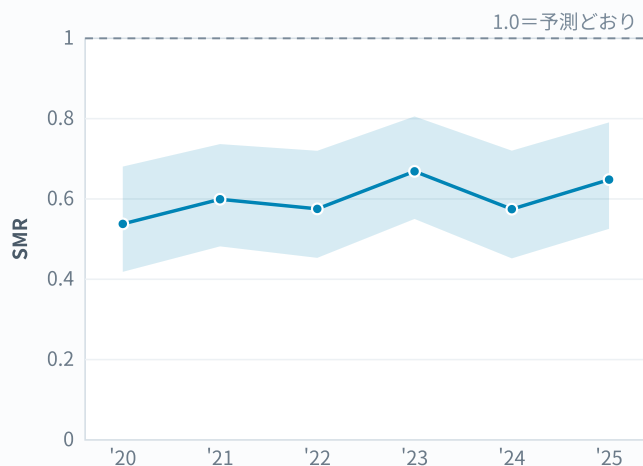
意味するところ：再入室は「早すぎる退室」の代表的な指標である。回転が速くなったこと（01）、退室後の死亡が増えたこと（02）と同じ方向を指しており、**同一の現象の別の側面である可能性がある。**

3. 診療の質は保たれている

死亡率の推移



SMR (APACHE III) 帯は95%信頼区間



SMRは0.65 (95%信頼区間 0.53～0.79)。6年間つねに信頼区間の上限が1を下回っている。重症な患者ほど死亡率は高くなるため、死亡率だけでは施設や年度を比べられない。重症度から予測される死亡数で割ったSMRが1を下回っていれば、予測より死亡が少ないことを意味する。

4. 病床と算定

病床利用率（8床）

90.2 %

▼ 3.2 pt 前年度 93.4%

満床の日数

146 日

正午時点の在室 3～8人

特定入院料の算定率

74.9 %

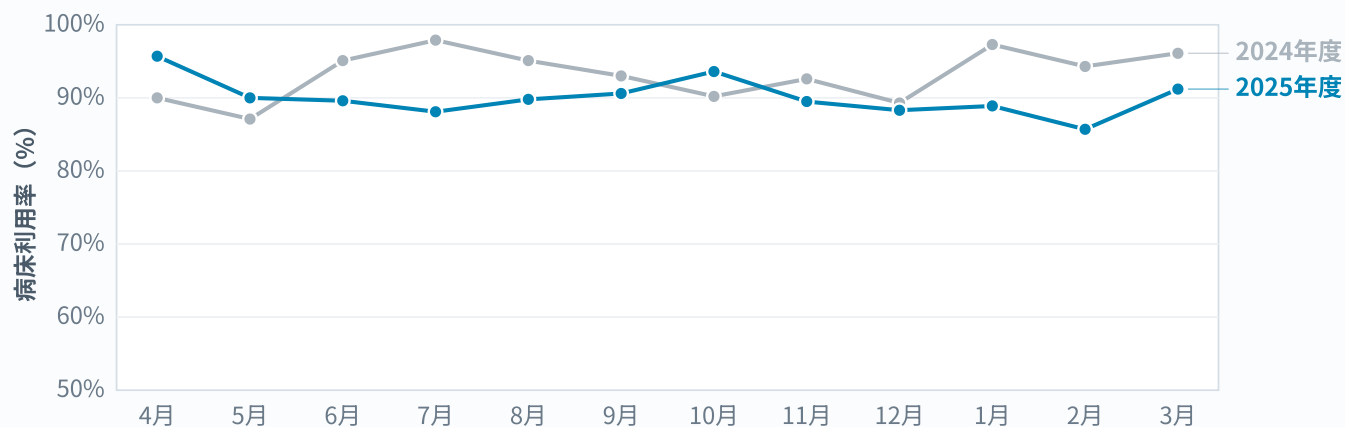
▼ 0.1 pt 前年度 75.0%

機会損失額（年間）

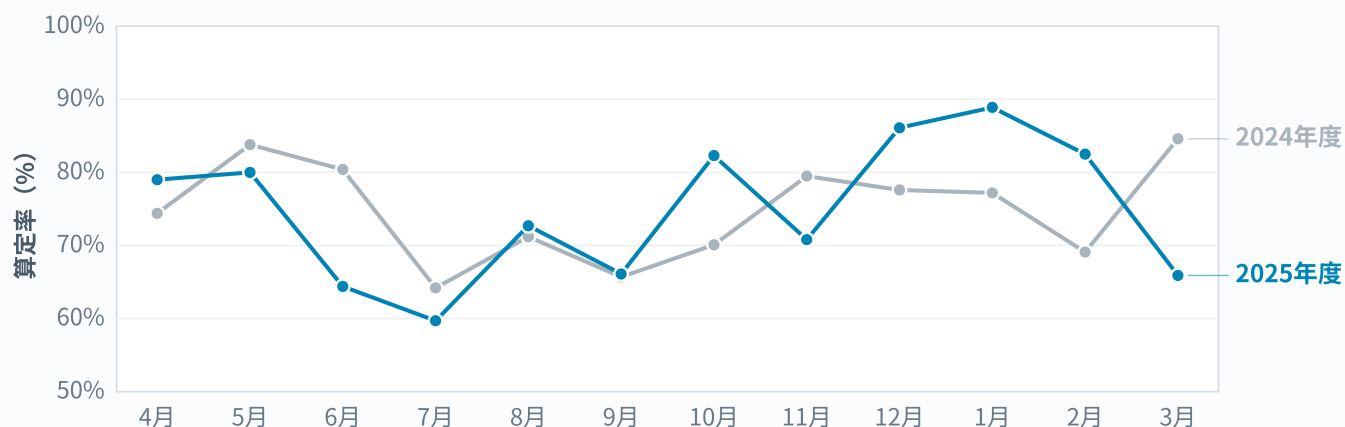
7,059 万円

▼ 338万円 前年度 7,397万円

月別 ICU病床利用率



月別 特定入院料の算定率



病床利用率・算定率・機会損失額は医事課の集計。月別の値は医事課のグラフから読み取った近似値（±1ポイント程度）で、年平均は医事課の表示値。

在室日数の長い上位10%の患者が延べ在室日数の41%、上位20%で58%を占める。15日以上の長期滞在47例（入室の8%）だけで延べ在室日数の36%を使った。長期滞在患者を1人減らす効果は、短期入室を数人減らす効果より大きい。

急性血液浄化・ECMOによる算定上限の延長（14日→25日。施設基準はJIPADへの症例登録）で、今年度は18例・130日分、約1,513万円を算定した。

5. データの入力状況

項目	2024年度	2025年度
主病名（疾患群名）	97%	96%
APACHE IIIスコア	100%	100%
退院時転帰	99%	99%
せん妄の有無	100%	100%
Charlson Risk Index	88%	96%
Clinical Frailty Scale	30%	93%
栄養開始までの時間	61%	53%
早期リハビリ開始日時	18%	20%
早期離床加算の算定有無	0%	100%

重症度・転帰など台帳の基本項目はほぼ全例そろっている。Clinical Frailty Scale と Charlson は再入力で今年度そろった（過去年度とは比べない）。リハビリ開始日時は記録が少なく、早期離床率はこの記録がある例だけで算出している。PT介入欄は2024年7月で運用を終えた。

付録：主要数値一覧

指標	2024年度	2025年度
入室患者数	553 例	587 例
延べ在室日数	3,257 日	3,157 日
ICU在室日数（中央値）	3.0 日	3.0 日
予定手術の割合	35.8%	39.9%
緊急入室の割合	64.9%	60.3%
ICU死亡率	4.7%	3.6%
院内死亡率	13.7%	16.6%
標準化死亡比（APACHE III）	0.57	0.65
再入室率	9.4%	12.3%
人工呼吸実施率	27.7%	23.3%
HFNC利用率	28.0%	21.6%
せん妄発生率	42.5%	35.4%
15日以上 of 長期滞在	50 例	47 例
早期経腸栄養率（48時間以内）	68.5%	55.6%
早期離床率（48時間以内）	52.6%	53.2%
在室患者数（正午時点の平均）	—	7.1 人
病床利用率（8床・医事課）	93.4%	90.2%

指標	2024年度	2025年度
特定入院料の算定率（医事課）	75.0%	74.9%
機会損失額（医事課）	7,397 万円	7,059 万円

早期経腸栄養率・早期離床率はICU滞在48時間超かつ18歳以上が対象。詳細な定義と分母は年次レポート詳細版を参照。

データ出典：20260904ICU症例統合全データ.xlsx / ExJIPAD_20260910102157.csv（医事課集計を除く）。詳細は「聖路加ICU
2025年度 年次レポート詳細版」を参照。
聖路加国際病院 集中治療科 ICU年次レポート 2025年度 ダイジェスト
院内資料。患者個人を特定する情報は含まれていません。